

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Inventario Obsesivo-Compulsivo Revisado (OCI-R)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Inventario Obsesivo-Compulsivo Revisado
Sigla	OCI-R
Autores	Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberger, S., et al.
Año	2002
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Obsesiones y compulsiones
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Fullana et al., 2005)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No se localizo formulario oficial independiente.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Obsesiones y compulsiones. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	6 dimensiones (Lavado, Comprobación, Orden, Obsesiones, Acumulación, Neutralización).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	18 ítems (3 por dimensión).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos sobre el grado de malestar en el último mes (0 = Nada, a 4 = Extremadamente).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	6 dimensiones (Lavado, Comprobación, Orden, Obsesiones, Acumulación, Neutralización).
Ítems	18 ítems (3 por dimensión).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 5 puntos sobre el grado de malestar en el último mes (0 = Nada, a 4 = Extremadamente).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria total (0-72) y por subescalas (0-12).

Regla de corrección	Sumatoria total (0-72) y por subescalas (0-12).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Un puntaje total ≥ 21 indica la probable presencia de TOC clínico.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

18 ítems. Mide específicamente dimensiones del TOC (lavado, comprobación, orden, obsesiones, acumulación, neutralización). Excelente consistencia interna (.81-.93).

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	18 ítems. Mide específicamente dimensiones del TOC (lavado, comprobación, orden, obsesiones, acumulación, neutralización). Excelente consistencia interna (.81-.93).
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Fullana et al., 2005)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Obsesiones y compulsiones en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S., et al.; 2002.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Fullana et al., 2005)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Obsesiones y compulsiones
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 18 ítems (3 por dimensión).; 6 dimensiones (Lavado, Comprobación, Orden, Obsesiones, Acumulación, Neutralización).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria total (0-72) y por subescalas (0-12).
Interpretación	Un puntaje total ≥ 21 indica la probable presencia de TOC clínico.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S., et al. (2002). Inventario Obsesivo-Compulsivo Revisado.

Fuente de referencia del catálogo: Disponible en artículos originales.

<https://doi.org/10.1037/1040-3590.14.4.485>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16243637/>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	OCI-R española, 18 ítems, seis dominios. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 576efc6 504 501 143d734 865c90d1fd29f327d1dcd55d9b3d685 260 967 970b236.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	OCI-R española, 18 ítems, seis dominios.
6. Periodo temporal	Último mes.
7. Escala/formato de respuesta	0–4.
8. Algoritmo de puntuación	Sumar los 18 ítems 0–4: total 0–72. Cada una de seis subescalas contiene tres ítems (0–12); usar la clave publicada de la versión española.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	Validación española N=381; estructura de seis factores y fiabilidad interna/test-retest de moderada a buena. Fullana et al. (2005).
11. Baremos, cortes e interpretación	Un puntaje total ≥ 21 indica la probable presencia de TOC clínico. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fullana et al. (2005), versión española, doi:10.1016/j.janxdis.2004.10.004, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16243637/ .
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.